

Po sześćdziesiątym *piątym*

Ta sama ilość alkoholu działa inaczej niż dwadzieścia lat temu. Zmieniają się limity, zmieniają się ryzyka, a leki przewlekłe wchodzą w interakcje.

CZAS: 12 min Psychoedukacja + interakcje z lekami

ŹRÓDŁO: NIAAA; Blow & Barry (2012); Blow i wsp. (1992, MAST-G)

JAK UŻYWAĆ

Trzy rzeczy w jednym arkuszu. Sekcja 01: **dlaczego limity są niższe** niż dla młodszych dorosłych. Sekcja 02: **interakcje z lekami przewlekłymi** (statyny, leki na ciśnienie, nasenne, leki przeciwbólowe). Sekcja 03: **samotność jako wyzwalacz** — często ukryta, a typowo silniejsza niż „nawyk”. Na końcu plan adresujący *funkcję* picia, nie tylko picie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Po 65. roku życia organizm **metabolizuje alkohol wolniej** — mniej wody w organizmie, mniej enzymu *ADH*, wolniejsza praca wątroby. *NIAAA* obniża limit picia niskiego ryzyka do **≤1 drinka dziennie** i ≤7 tygodniowo dla osób w tym wieku. Polifarmacja jest normą — przeciętny senior bierze 4–7 leków, z których kilka wchodzi w istotne interakcje z alkoholem. *Blow & Barry* (2012, badanie kontrolowane *RCT*): krótka interwencja u seniorów **działa lepiej** niż u młodszych dorosłych ($NNT \approx 6$), ale tylko jeśli problem zostanie rozpoznany. *MAST-G* i *AUDIT* z obniżonym progiem (≥ 5) są dla tej grupy bardziej czułe.

01 Dlaczego ta sama ilość działa silniej

MNIEJ WODY W ORGANIZMIE

Z wiekiem zmniejsza się udział wody, rośnie udział tkanki tłuszczowej. Ta sama dawka alkoholu rozcieńcza się w **mniejszej objętości** — wyższe stężenie we krwi.

WOLNIEJSZY METABOLIZM

Wątroba pracuje wolniej, mniej enzymu *ADH*. Alkohol jest **dłużej obecny w krążeniu** — to samo upojenie trwa dłużej, kac jest cięższy.

WRAŻLIWSZY MÓZG

Starsze neurony są wrażliwsze na działanie hamujące alkoholu. Sedacja, splątanie, zawroty — pojawiają się przy **niższych dawkach**.

Limit picia niskiego ryzyka po 65. r.ż. (NIAAA): maksymalnie **1 drink na dzień i 7 drinków na tydzień**, niezależnie od płci. Minimum dwa dni bez alkoholu w tygodniu. Powyżej — picie ryzykowne dla tej grupy wiekowej, nawet jeśli było „bezpieczne” w młodości.

02 Interakcje z lekami — cztery grupy o największym znaczeniu

LEKI NASENNE I USPOKAJAJĄCE

Benzodiazepiny (klonazepam, oksazepam), *zopiklon*, leki przeciwhistaminowe nasenne. Z alkoholem: **podwójna sedacja**, upadki, splątanie, ryzyko zatrzymania oddechu.

LEKI NA CIŚNIENIE

Inhibitory *ACE*, blokery wapnia, beta-blokery. Z alkoholem: **spadki ciśnienia po wstaniu** (hipotensja ortostatyczna) → upadki, omdlenia.

LEKI PRZECIWBÓLOWE

Paracetamol + alkohol = wzrost obciążenia wątroby. *Ibuprofen*/inne *NLPZ* + alkohol = ryzyko krwawienia z żołądka i jelit. Opioidy + alkohol = ryzyko zatrzymania oddechu.

LEKI NA DEPRESJĘ I PRZECIWKAKRZEPOWE

SSRI/SNRI + alkohol = większe ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. *Warfaryna*/nowe antykoagulanty + alkohol = nieprzewidywalne stężenie, ryzyko krwawień.

03 **Samotność jako wyzwalacz — często niedostrzegane sedno problemu**

U seniorów alkohol często nie jest „nawykiem”, tylko sposobem radzenia sobie z trudniejszymi emocjami. **Emerytura, strata partnera**, dzieci, które wyprowadziły się daleko, choroba przewlekła, brak rytmu dnia — to wszystko jest czynnikiem napędzającym picie po godzinach. Dwa profile, które klinicyści wyróżniają.

PICIE WCZESNO-ROZPOCZĘTE

Osoba piła już przez dziesięciolecia, problem narastał stopniowo. Często z towarzyszącymi powikłaniami (wątroba, mózg). Wymaga leczenia kompleksowego.

PICIE PÓŹNO-ROZPOCZĘTE

Picie znacząco wzrosło po 60. roku życia, często po stracie partnera lub przejściu na emeryturę. *Lepsze rokowanie* — adresowanie samotności adresuje korzeń.

Praktyczna obserwacja: niewyjaśnione upadki, „splątanie demencyjne”, bezsenność i nasilenie depresji u seniora — zawsze warto sprawdzić rolę alkoholu, zanim ustabilizuje się rozpoznanie.

04 **Mój plan — adresuję funkcję, nie tylko picie**

Sama redukcja picia bez zaadresowania powodu (samotność, brak rytmu, ból) najczęściej nie działa. Kierunek: *zastąpić* funkcję, nie tylko zabrać butelkę.

NAJTRUDNIEJSZA PORA DNIA

— *kiedy najczęściej sięgam po alkohol*

CO WTEDY NAJCZĘŚCIEJ CZUJĘ

— *samotność, nuda, lęk, ból, smutek*

AKTYWNOŚĆ, KTÓRĄ WPROWADZĘ W TEJ PORZE

— *np. spacer, telefon do rodziny, klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, spotkanie AA dla seniorów, wolontariat*

OSOBA, KTÓRA ZADZWONI DO MNIE RAZ W TYGODNIU

— *umowa*

Z LEKARZEM SKONSULTUJĘ

— *interakcje moich leków z alkoholem*

Klucz: Picie u seniorów jest *najczęściej niedodiagnozowane* w opiece zdrowotnej (Blow, 2012). Lekarze rzadko pytają, seniorzy rzadko zgłaszają. **Sam fakt zadania pytania** — przez Ciebie, dziecko lub lekarza POZ — często wystarczy do otwarcia tematu. Nie pytaj „czy Pan/Pani pije” (zamknięte) — pytaj „ile drinków wypija Pan/Pani w typowy tydzień” (otwarte, kwantyfikujące). Krótka interwencja w tej grupie wiekowej działa lepiej niż u młodszych dorosłych.